Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0027954-13.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): ANGELA MARIA MARA DE BRITO

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

-

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.

- Enunciado 33, da I jornada de direito da saúde do CNJ, que recomenda aos magistrados a análise dos pareceres técnicos da agência nacional de saúde suplementar e da comissão nacional de incorporação de tecnologias no SUS (CONITEC) na prolatação de decisão.

- Atenção à lei 9.656/98 ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, RN nº 465, de 24/02/2021.

- Fornecimento de medicamentos não oncológicos. Recusa amparada nas exceções do art. 10, VI, da lei 9.656/98; inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN nº 465, de 24/02/2021; parecer técnico nº 20/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024.

Vistos etc.

Ângela Maria Mara de Brito, qualificada, ingressou com Ação de Procedimento Comum de Obrigação de Fazer em face de Bradesco Saúde S/A, igualmente identificada.

Expôs ter, atualmente, 69 anos, sendo portadora de osteoporose grave diagnosticada em outubro de 2024, tendo tentado tratamentos convencionais de primeira linha, mas sem sucesso.

Disse que sua médica assistente, Dra. Ana Cláudia Ramos, solicitou, em novembro de 2024, a cobertura de tratamento com o medicamento Romosozumabe 90 mg/ml, a ser ministrado na quantidade de duas doses mensais durante um ano, totalizando 24 aplicações.

Informou que, após dois meses sem resposta, foi reiterado o pedido à operadora de saúde em fevereiro de 2025, mas a ré, passados quase quinze dias, negou cobertura, sem qualquer fundamentação clara.

Sustentou ser a negativa abusiva, baseada em cláusula contratual unilateral, sem considerar a prescrição médica e a urgência da situação, agravada pelo risco de fraturas severas em virtude da fragilidade óssea.

Acrescentou que vem arcando com os altos custos do tratamento e que a mensalidade do plano alcança o montante de R$ 3.984,47, comprometendo sua subsistência.

Requereu a autorização e fornecimento imediato do medicamento Romosozumabe e demais procedimentos necessários para o controle da osteoporose, bem como a condenação da ré ao pagamento de reembolso pela realização do exame de PETSCAN custeado de modo particular, no valor de R$ 5.000,00 e por danos morais em razão do abalo psicológico pela negativa indevida.

Deu à causa o valor de R$ 10.000,00.

Pediu a gratuidade da justiça.

Acostou documentos.

Ordem de emenda para: " *a) acostar cópia do instrumento de contrato firmado com a demandada de forma legível, eis que imprescindível que seja especificado e provado qual o tipo de pacto firmado e as suas condições ; b) efetuar pedido certo e determinado, nos moldes do art. 322 e 324, do CPC, esclarecendo os itens "a" e "d" do pedido, com valores do tratamento pugnado, não podendo ser genérico o pedido, cabendo sua quantificação; c) retificar o valor atribuído à causa, levando em consideração o valor do tratamento/exame pretendido somado ao valor indenizatório; d) quitar custas."*

Manifestação da parte autora dizendo pretender tutela provisória de urgência para que a ré seja compelida a autorizar a cobertura/fornecimento da medicação ROMOSOZUMABE 90mg/ml (duas doses por mês durante um ano – 24 doses), para o tratamento de osteoporose, com confirmação ao final e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu o aditamento do valor da causa para R$ 65.620,00.

Decisão alterando o valor da causa para R$ 65.620,00 e ordenando emenda.

Quitação de custas.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação (Id. 206930567), arguindo, em preliminar, a carência de ação por ausência de pretensão resistida. No mérito, sustentou, em resumo, que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, excluindo a cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

Aduziu que, ainda que aplicável a legislação atual, a autora não preenche os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS para o fornecimento do medicamento, que exigiria a comprovação de ao menos duas fraturas prévias, o que não foi demonstrado.

Defendeu a legalidade de sua conduta e a inexistência de danos morais.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 207432093), a parte ré requereu a realização de perícia médica judicial para apurar se há real necessidade do tratamento nos moldes requisitados e a parte autora apresentou réplica (Id. 210184743), rechaçando a preliminar e reiterando os argumentos da inicial, notadamente a abusividade da negativa e da exigência de fraturas prévias para a concessão do tratamento preventivo e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório, passo à decisão.

Afasto a preliminar de carência de ação por ausência de pretensão resistida, pois há nos autos prova inequívoca da pretensão resistida com o documento de Id. 199614259, que comprova que a ré, por meio de ofício formal datado, negou expressamente a cobertura do tratamento solicitado pela autora, apresentando fundamentação técnica e jurídica para a recusa.

Sabe-se que não se deve praticar atos inúteis, que representarão atraso na marcha processual, como diz o artigo 370 do CPC (antigo artigo 130, CPC, com pequenas modificações):

> "*Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.*
>
> *Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."*

Ensina Vicente Greco Filho:

> *"A segunda parte do art.130 é uma decorrência de poder do juiz de velar pela rápida solução do litígio. Deverá ele impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias."* (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, São Paulo, 1999, 14ª edição, Volume I, pág.228).

Leciona Vicente Miranda:

> *"A emissão de um juízo judicial de admissibilidade ou de inadmissibilidade deste ou daquele meio de prova funda-se na necessidade de serem evitadas provas inúteis ou desnecessárias ou protelatórias, que aumentariam os gastos do processo e retardariam seu normal desenvolvimento e conclusão. Sistematizando a matéria, podemos afirmar que o juízo de admissibilidade da prova obedece a quatro condições: a previsão legal, a tempestividade, a necessidade e a idoneidade."* (Poderes do juiz no processo civil brasileiro, Editora Saraiva, São Paulo, 1993, pág.213)."

Ressalto, outrossim, que apenas são produzidas provas que influenciem no convencimento do magistrado, quem dirige o processo e é o destinatário das provas. Como leciona Cassio Scarpinella Bueno: "*É que na medida em que o juiz (..) estiver convencido das alegações das partes ou de terceiros, não há razão para se produzir qualquer prova".[1] (file:///C:/Users/ir/Desktop/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Romozumabe%20-%20Osteoporose.docx#_ftn1)*

Assim já entendeu o egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:

"Com efeito, o princípio fundamental da ampla defesa não produz o dever de efetivamente serem produzidas provas em um determinado processo, isso porque sua oportunidade e conveniência estarão sempre submetidas ao princípio do livre convencimento ou da persuasão racional do magistrado, podendo este decidir quais provas serão relevantes para o deslinde do conflito ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que "o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é o suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. (AgRg no Ag 834.707/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, julgado em 27/03/2007). In casu, o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa. As questões de fato e de direito já se encontravam suficientemente esclarecidas pela prova documental acostada aos autos, sendo lícito ao magistrado conhecer diretamente do pedido (art. 330, I, do CPC).

Ademais, infere-se dos autos que na audiência conciliatória o magistrado a quo anunciou o julgamento antecipado da lide, sem que qualquer das partes tenha se insurgido contra o referido pronunciamento. Desta forma, mostra-se totalmente despropositada a arguição de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, na medida em que o seu desinteresse quanto à especificação de provas operou a preclusão da matéria. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NOVAS PROVAS. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. PRODUÇÃO. DISPONIBILIDADE. DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. REVISÃO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. - (...) - Tendo o recorrente feito valer a disponibilidade do direito à produção de provas, abrindo mão daquelas que, embora anteriormente requeridas e deferidas, até então não haviam sido produzidas, não há como admitir a sua alegação de cerceamento de defesa, apenas porque lhe sobreveio sentença desfavorável. - As Súmulas nºs 05 e 07 do STJ vedam o reexame do substrato fático probatório dos autos no âmbito do recurso especial. Recurso especial não conhecido. (REsp 810.667/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 05/11/2008). Assim, deve ser afastada a argüição de cerceamento de defesa." (Apelação nº 0002674-15.2011.8.17.0810 (0279844-3), 6ª Câmara Cível, Relator Des. Eduardo Augusto Paurá Peres, Julgado em 23/10/2012, DJe Edição nº 206/2012, 6/11/2012, p. 172)

"DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA CONVERTIDA EM FEITO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO POR INVALIDEZ. APELO IMPROVIDO. - Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. Alegação de nulidade da sentença, em face do julgamento antecipado da lide, ao argumento de cerceamento de defesa, alegando que se fazia mister produção de prova pericial. Quanto a isso, percebe-se, da análise da douta sentença, que não há nulidade do processo por cerceamento de defesa por ter o magistrado se valido do instituto prescrito no art. 330, I do Código de Processo Civil. Os fatos objeto da demanda encontravam-se suficientemente demonstrados, de modo a dispensar produção de provas outras, vez que a solução do litígio poderia ser extraída das carreadas aos autos, restando aptas a embasar o convencimento do julgador. Com efeito, diante da concessão do benefício junto ao INSS, restou despicienda a realização de perícia para aferição da invalidez permanente. (...). - Ademais, conforme alhures explicitado, a concessão de aposentadoria pelo INSS se mostra suficiente a embasar o pleito do exeqüente, máxime tendo em conta o rigor com que referida autarquia previdenciária age para a concessão dos benefícios. - Ora, a concessão pelo órgão previdenciário é prova inequívoca da invalidez que acometeu o exequente, que, inclusive, fora submetido a intervenção cirúrgica por conta de um tumor maligno de boca, com metástase cervical. Com efeito, a invalidez deve ser havida por permanente quando o segurado se vê impossibilitado de exercer o labor para o qual estava apto antes de ser acometido pela enfermidade. Não tem como prosperar a alegação de que o segurado não se encontra impossibilitado de exercer outras profissões, até porque não é plausível exigir que o mesmo desenvolva aptidão

para exercer atividade laborativa que nunca exerceu antes. - Por derradeiro, no que tange às argumentações deduzidas em sede de contrariedade ao apelo, não tem como prosperar. - A pena a que foi condenado o apelante, tendo em conta a interposição de embargos havidos por protelatórios, não impede o ajuizamento de quaisquer recursos. Apenas no caso de reiteração de aclaratórios protelatórios é que a multa eleva-se a 10%, e a interposição de outros recursos fica condicionada ao depósito de referido montante, o que não é o caso dos autos. - No mais, a ausência de qualificação do recorrido em autos de apelo, não tem o condão de macular a insurgência recursal, máxime porque o mesmo atingiu o seu desiderato, de explicitar, tempestivamente, as razões de reforma em que se baseia o apelante, tudo com espeque no art. 154 do CPC. - Negativa de provimento ao presente apelo, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença combatida. - Por unanimidade, negou-se provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator." (TJ-PE - APL: 40543 PE 71757-9, Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 09/05/2012, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 105)"

Da mesma forma o STJ:

"PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula nº 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJe 29/6/2011)."

Analisando os autos, verifico haver elementos suficientes à apreciação de mérito. Assim, rejeito a prova requerida pela parte ré, o que faço lastrada no entendimento de que o magistrado que preside também orienta a produção probatória e lhe cabe indeferir provas que não sirvam ao desfecho da lide.

LIDE

A jurisprudência pátria vem sofrendo para estabelecer decisões em casos de cobertura de procedimentos por contratos de assistência à saúde, pois, de um lado, há toda uma gama de direitos estabelecidos em favor da saúde, personalidade e consumidor, havendo, porém, a necessidade de preservação da viabilidade econômica das empresas que ofertam tais pactos e do equilíbrio das contraprestações.

Para tanto, este juízo tem se amparado das normas que lastram ambas as vertentes e das normativas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), criado pela Lei 9.656/1998, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, instituída pela Lei 9.961/00, para regulação e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar.

O Enunciado 33, da I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, dispõe aos magistrados que atentem para os pareceres técnicos das agências reguladoras:

"*ENUNCIADO N.º 33 Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar* e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)** para auxiliar a prolatação de decisão ou a propositura da ação."*

As Diretrizes de Utilização (DUT) são regras e normas elaboradas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) que servem para orientação e regulamentação do uso adequado de procedimento médicos e exames complementares, sendo descritas e baseadas em estudos médicos com a finalidade de utilização das novas tecnologias ou exames que realmente possam trazer benefícios para o paciente ou que auxiliem os médicos no diagnóstico de doenças.

Ressalto que o chamado Plano de Referência foi instituído pelo art. 10 da lei 9.656/98 como aquele com "*cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (...)"* (redação da MP 2.177-44/2001).

Afere-se que mesmo o plano de referência não possui cobertura ilimitada, pois há exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS.

O pedido foi de **fornecimento de medicamentos**, cabendo ser observado que mesmo o plano de referência não possui tal cobertura, havendo exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS. Assim o art. 10 da lei 9.656/98:

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)*
>
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)*
>
> *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
>
> *III - inseminação artificial;*
>
> *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
>
> *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art2) (Vigência) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art3)*
>
> *VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)*
>
> *IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*
>
> *X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente."*

Algumas dessas exceções constam do inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN nº 465, de 24/02/2021:

> *"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.*
> *Parágrafo único. <u>São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:</u>*
> *(...)*
> *VI - <u>fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,</u> isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;*

O PARECER TÉCNICO Nº 20/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024[2] (file:///C:/Users/ir/Desktop/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Romozumabe%20-%20Osteoporose.docx#_ftn2), que trata dos medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, diz ser obrigatória a cobertura para:

> *"a) medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso XI, da RN n.º 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.º 465/2021; e*
>
> *b) medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.º 9.656/1998 c/c art. 13, da RN n.º 465/2021; e*
>
> *c) medicamentos que eventualmente constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes."*

No presente caso, <u>não</u> **se trata de pedido de fornecimento de medicação oncológica domiciliar nem de negativa de um exame ou de um tratamento hospitalar**, mas da medicação Romosozumabe, para tratamento de osteoporose, conforme laudo de id 199614261, a ser tomada em forma de injeção subcutânea no domicílio, não estando coberto pelo contrato firmado e nem constando no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS (RN nº 465/2021), pelo que descabe cobertura, pois não resta obrigatório seu fornecimento pelo plano de saúde.

Trago à luz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. <u>É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim</u>. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta*

de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989033 DF 2022/0062136-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)" (grifos para destacar)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE S AÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA COMO NEOPLÁSICO. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2031280 MG 2022/0317722-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)" (grifos para destacar)

Incluo julgados do Tribunal de Justiça de Pernambuco no mesmo sentido de ausência do dever de cobertura de medicamentos domiciliares não oncológicos pela operadora de saúde suplementar:

"PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Autora portadora de trombocitopenia imune (PTI), sendo-lhe prescrito tratamento com uso contínuo do medicamento Revolade 50mg. 2. Medicamento de uso domiciliar; lícita a conduta do plano de saúde que se recusa a custear medicamento expressamente excluído da cobertura. 3. Obrigar as seguradoras a cobrir os medicamentos de uso domiciliar prescritos pelos médicos assistentes resultaria em significativo aumento dos custos, e, sem o aumento da contraprestação, se estaria a lesionar a comutatividade e o equilíbrio contratual. 4. O art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 possibilita às operadoras restringirem o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, razão pela qual a limitação está em consonância com a legislação pertinente e não se mostra abusiva frente aos princípios e normas que regem os direitos do consumidor. 5. Destaque-se que não se está diante de negativa de medicamento substituto das internações hospitalares ou ambulatoriais para sessões de quimioterapia, isso porque os medicamentos utilizados em concomitância com a quimioterapia e radioterapia não se inserem na regra de exclusão do artigo 10, VI, da lei 9656/98, que permite a exclusão contratual do fornecimento de medicação domiciliar. 6. O medicamento requerido não se encaixa em nenhuma das hipóteses de cobertura previstas na Lei n. 9.656/1998, não havendo, bem por isso, obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde. 7. Sentença reformada. 8. Provimento do recurso. (TJ-PE - AC: 00007095520228172640, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1ª TCRC))" (grifos para destacar)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MONITOR E SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ÍNDICES GLICÊMICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO PELA SEGURADORA. TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O cerne da demanda consiste em averiguar o dever da Agravada em custear o tratamento perseguido nos autos - monitor e sensor contínuo de glicemia (FREESTYLE LIBRE). - Conforme estabelecido na Lei nº 9.656/98 e precedentes do c. STJ, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados (arts. 10, VI e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98). - Portanto, encontram-se excluídos da cobertura pelos planos de saúde aquelas medicações/insumos adquiridos facilmente em farmácias e cuja aplicação (uso) pode se dar no âmbito domiciliar (Precedentes c. STJ). - Do mesmo modo, diante da desnecessidade de intervenção médico-cirúrgicas relacionadas ao fornecimento do aparelho, encontram-se excluídos da cobertura obrigatória pelas operadoras, nos termos do art. 10, VII, da Lei de regência. - Recurso desprovido. (TJ-PE - AI: 00166532920228179000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)" (grifos para destacar)"

"PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AFASTAR JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA E PRELIMINAR DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS REJEITADA. MEDICAMENTO INVEGA SUSTENA. ESQUIZOFRENIA CRONICA. NEGATIVA. DOMICILIAR (NENHUMA HIPOTESE DO ARTIGO art. 10,VI, e 12 da Lei nº 9.656/1998. FÁRMACO QUE NÃO SE RELACIONA A TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO, NEM DE USO HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. EXCLUSÃO ANS. ROL TAXATIVO. RECUSO DA RÉ PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório. Precedentes STJ. 2. In casu, EMBORA comprovada a necessidade de a paciente utilizar o medicamento solicitado como única terapia disponível, o Plano de Saúde não possui o dever de custear o medicamento de uso domiciliar (Invega Sustenna), pois extrapolaria os limites contratuais e legais, 3. Dado o provimento do recurso, inverte-se a sucumbência e fixa-se honorários advocatícios em R$ 500,00. 4. Recurso provido. (TJ-PE - AC: 00702011920198172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))" (grifos para destacar)"

Deixo de analisar o pedido contido na inicial de condenação da ré ao pagamento de reembolso pela realização do exame de PETSCAN, por ter sido retirado em sede de emenda de id 200795620.

Ante o exposto, **julgo improcedentes** os pedidos.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao procurador adversário, com base no art. 85, § 2º, do CPC, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, que suspendo conforme art. 98, §5°, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.

Recife, 29 de julho de 2025.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

---

[1] (file:///C:/Users/ir/Desktop/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Romozumabe%20-%20Osteoporose.docx#_ftnref1) Curso sistematizado de direito processual civil. Vol 2 Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 235.

[2] (file:///C:/Users/ir/Desktop/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Romozumabe%20-%20Osteoporose.docx#_ftnref2) Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2024/parecer-tecnico-no-20_2024_medicamentos-para-tratamento-domiciliar.pdf (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2024/parecer-tecnico-no-20_2024_medicamentos-para-tratamento-domiciliar.pdf)> ACESSO EM 17/03/2025.

Assinado eletronicamente por: IASMINA ROCHA
29/07/2025 19:12:40
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 211154882

25072919123999600000205591308

IMPRIMIR GERAR PDF